

INFILTRACIÓN DE RODILLA

Paula Leonor Vilorio Vecino, Rubén Escudero Gonzalez, Julio Tito Camino Acha, Humera Safir Jabeen, María Martín Gaitero, Raúl Marcos Mesa, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

La rodilla esta formada por:

- La articulación femoropatelar y tibiofemoral
- Estructuras periarticulares y ligamentos laterales

Material

- Gasas, guantes y campo estéril, povidona yodada, alcohol
- Jeringa de 5 y 10 ml
- Aguja de 0,8 x 25 mm (21 G) (verde, intramuscular).
- Aguja de 0,9 x 25 mm (20 G) (amarilla intravenoso/intramuscular)
- Parametasona 40 mg / 2 ml (Cortidene depot®)
- Triancinolona 40 mg / 1 ml (Trigon depot®)
- Betametasona 12 mg / 2 ml (Celestone Cronodose®)
- Anestésico local Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor: 2 ml

TÉCNICAS

Abordajes

Abordaje suprapatelar lateral

Paciente en decúbito supino.

Punto de entrada:

- En primer lugar, identificamos la superficie superior de la rótula y se traza una línea horizontal a un dedo de distancia del margen superior.
- A continuación, se identifica el borde posterior de la rótula y se dibuja una línea vertical. Se identifica el punto de intersección de ambas líneas que representa el punto de entrada de la aguja.
- Introducimos la aguja perpendicular a la piel y paralela al plano de la camilla.
- Con esta vía accedemos al receso o bolsa suprapatelar, sin impactar contra la rótula.

Abordaje subrotuliano

- Puede realizarse tanto por vía externa como interna.
- De elección la vía externa, menos dolorosa y de fácil acceso.
- Paciente en decúbito supino.

Punto de entrada vía externa:

- En primer lugar identificamos la interlínea femorotibial.
- Se presiona el borde interno de la rótula con la mano para elevar el borde rotuliano externo.
- El punto de inserción se hará por debajo del alerón externo de la rótula, en la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior de la misma, introduciendo la aguja perpendicular a la piel y paralela a la rótula.
- El abordaje interno es similar al anterior pero más doloroso e incómodo a la punción, lo que hace que sea una vía de menor uso.

- En caso de que la aguja contacte con la porción anterior del fémur, corregir el trayecto hasta el espacio articular sin extraer la aguja completamente.
- La presión manual sobre el receso suprapatelar simultáneamente facilitará la salida de líquido.

Abordaje anterior pararotuliano

- Paciente con rodilla flexionada.
- Puede realizarse tanto para el compartimento externo como interno.
- De elección el externo, ya que es menos doloroso a la punción.

Punto de entrada:

- En primer lugar, palpamos la interlínea articular y el tendón rotuliano.
- El punto de inserción se realizará a 1 cm lateral al tendón rotuliano y 1 cm por encima de la interlínea articular.
- Se dirige la aguja perpendicular a la piel hacia el espacio intercondíleo y paralela al plano del platillo tibial.
- En caso de encontrar resistencia o impactar con el cóndilo femoral, reconducir la aguja sin extraerla completamente.

Tendinitis de la pata de ganso - Bursitis anserina

Clínica:

Dolor en la cara interna de la región proximal de la tibia. La pata de ganso es la inserción común de los músculos semitendinoso, sartorio y recto interno.

Punto de entrada:

- Decúbito supino.
- Se utilizará una aguja de pequeño calibre.
- Se localiza el punto más doloroso en la porción anterior medial del extremo proximal de la tibia.
- En el punto más doloroso, se introduce la aguja hasta el hueso. Se retira la aguja 1-2mm y se infiltra en forma de abanico la zona de máximo dolor.
- En caso de encontrar resistencia, se avanzará o retrocederá la aguja y se continuará introduciendo la solución.

Infiltración del muro meniscal interno

Útil en pacientes con clínica meniscal interna y dolor localizado. Paciente con la rodilla en flexión.

Punto de entrada: a nivel de la interlínea articular postero-interna.

Dirección: oblicua hacia la zona capsular postero-interna.

Bursitis prerotuliana

Paciente en decúbito supino y rodillas en extensión.

Punto de entrada:

- Se identifica el punto de mayor fluctuación de la bolsa articular.
- Se introduce la aguja oblicua, casi paralela a la piel, hasta llegar a la bursa.
- Redirigir la aguja en varias direcciones y presionar con la mano contralateral para facilitar la

salida de líquido, ya que el derrame suele estar tabicado.

BIBLIOGRAFÍA

- McNabb JW. Infiltraciones. Madrid: Marbán libros SL; 2017.
- McRae R. Ortopedia y fracturas. Exploración y tratamiento. Madrid: Marbán libros SL; 2013.
- Gil Vicent JM. Colell Mitjans F. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos en aparato locomotor. Barcelona: Grup Barcelona de medicina ortopédica i manual; 2009.